PROTOCOLLO 98

Gestione della riacutizzazione

Pianificare cosa fare quando il dolore ritorna

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Riacutizzazione dei sintomi	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ritorno del dolore dopo un periodo di benessere
- ✓ Periodi di stress o cure dentali
- ✓ Paziente vicino alla dimissione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Riconoscimento
Identifica i segnali precoci con il paziente.



Piano
Scrivi un piano di 72 ore: dieta morbida, calore o freddo, esercizi dolci.



Monitoraggio
Se dopo 1 o 2 settimane non migliora, contatta il fisioterapista.



Revisione
Analizza i fattori scatenanti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Piano	72 ore
Contatto	dopo 1 o 2 settimane senza miglioramento
Strumento	scheda scritta

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Le riacutizzazioni sono normali e gestibili
- ✓ Il paziente diventa autonomo
- ✓ Piano scritto e personalizzato

Errori da evitare

- ! Interpretare la riacutizzazione come fallimento
- ! Riposo assoluto prolungato
- ! Abbandonare gli esercizi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Piano di riacutizzazione	Seguire le 72 ore del piano personale	quando i sintomi tornano

! **Nota clinica.** Un piano di riacutizzazione riduce l'ansia e i ritorni non necessari in studio.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.